

Ambliopía (“Ojo perezoso”)

1. Introducción y relevancia clínica

La **ambliopía** es una disminución de la agudeza visual **sin causa orgánica aparente**, que resulta de una **estimulación visual anómala o desigual durante el desarrollo visual temprano**.

El ojo afectado es estructuralmente normal, pero el cerebro **aprende a “ignorar” su imagen**, suprimiéndola para evitar diplopía o confusión visual.

Definición según la OMS / MINSAL:

“Reducción unilateral o bilateral de la agudeza visual, de causa funcional, que no mejora con corrección óptica adecuada y que se desarrolla durante el período de plasticidad visual.”

Relevancia clínica:

- Es la **principal causa de pérdida visual unilateral en niños y adultos jóvenes**.
- Afecta entre **2–4%** de la población infantil.
- Su **detección precoz y tratamiento antes de los 8 años** pueden restaurar completamente la visión.
- Es **pregunta clásica en EUNACOM**: suelen presentar un niño con estrabismo o diferencia refractiva que “ve menos” de un ojo sin lesión visible.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Desarrollo visual normal

- El sistema visual humano es **inmaduro al nacer**.
- Durante los primeros **7–8 años de vida**, la retina y la corteza visual desarrollan conexiones neuronales dependientes del estímulo visual recibido por ambos ojos.
- Este periodo se denomina “**período crítico**” de plasticidad visual.

2.2 Mecanismo fisiopatológico

Cuando la visión de un ojo se ve **privada, distorsionada o desenfocada** durante el período crítico, la corteza visual **favorece las aferencias del ojo sano y suprime las del ojo afectado**.

El resultado es una **disminución cortical funcional** de la visión en el ojo afectado, aun cuando las estructuras oculares sean normales.

2.3 Causas principales de ambliopía

Tipo	Mecanismo	Ejemplo clínico
Estrábica	Supresión del ojo desviado para evitar diplopía.	Endotropía congénita o adquirida.
Refractiva (anisometrópica)	Diferencia de refracción entre ambos ojos → imagen borrosa en uno.	Hipermetropía o astigmatismo asimétrico.
Por privación	Falta de estímulo visual por opacidad u oclusión.	Catarata congénita, ptosis severa, opacidad corneal.
Amblio-isoametropía	Errores refractivos bilaterales altos no corregidos.	Hipermetropía o miopía significativa bilateral.

Frecuencia relativa:

- Estrábica (≈50%),
 - Refractiva (≈25%),
 - Por privación (≈10–15%),
 - Otras (≈10%).
-

2.4 Plasticidad visual y edad crítica

- Máxima hasta los **6 años**.
 - Disminuye progresivamente hasta los **8–9 años**, cuando el sistema visual se estabiliza.
 - Después de esa edad, la recuperación visual es **parcial o nula**, incluso con corrección o cirugía.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas

- Disminución de la **agudeza visual en un ojo**, sin hallazgos estructurales.
- **Desviación ocular** (estrabismo concomitante).
- **Tortícolis ocular** o inclinación de cabeza.
- **Cierre de un ojo** con luz brillante o esfuerzo visual.
- **Dificultad para reconocer objetos o letras pequeñas** en un ojo.
- En lactantes: falta de fijación o seguimiento visual.

Los niños **no suelen referir síntomas** porque el ojo sano compensa la visión.

3.2 Hallazgos en el examen físico

1. **Agudeza visual disminuida** en un ojo (test de Snellen, optotipos o dibujos).
 2. **Reflejo rojo normal**.
 3. **Reflejos corneales centrados o desviados** (estrabismo asociado).
 4. **Refracción desigual** (anisometropía).
 5. **Movimientos oculares normales o desviados**.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferenciación clínica
Errores refractivos simples	Mejoran con corrección óptica.
Catarata o patología media ocular	Reflejo rojo alterado, opacidad visible.
Lesiones retinianas o del nervio óptico	Hallazgos en fondo de ojo (atrofia, edema, cicatriz).
Agnosia visual / causas corticales	Fondo de ojo normal, pero bilateral y con otros déficits neurológicos.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria

1. **Medición de agudeza visual monocular** (según edad):
 - <3 años: seguimiento visual y test de fijación.
 - 3–5 años: test de figuras (Lea o Allen).
 - 6 años: optotipos o Snellen.
 2. **Reflejo rojo:** descartar opacidades (catarata, retinoblastoma).
 3. **Reflejo corneal (Hirschberg) y cover test:** para estrabismo.
 4. **Derivación inmediata** si AV <0,8 en un ojo o diferencia ≥ 2 líneas entre ambos.
-

4.2 En atención especializada

Examen	Objetivo
Refracción bajo cicloplejía	Detectar anisometropía o ametropía alta.
Test de fusión y estereopsis (Lang, Titmus)	Evalúa función binocular.
Motilidad ocular completa	Valora presencia de estrabismo.
Fondo de ojo	Excluye patología orgánica.
Potenciales evocados visuales	En casos dudosos o simulación.

4.3 Criterios diagnósticos

Diagnóstico clínico de exclusión:

1. Disminución de agudeza visual en uno o ambos ojos.
 2. Estructuras oculares normales.
 3. No mejora completamente con corrección óptica.
 4. Presencia de factor de riesgo (estrabismo, anisometropía, privación visual).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

El tratamiento busca **estimular la visión del ojo afectado** durante el período plástico y **corregir la causa subyacente**.

5.1 Principios generales

1. **Tratar la causa primaria.**
 2. **Estimular el ojo ambliope.**
 3. **Mantener visión binocular.**
 4. **Iniciar tratamiento precoz (<6 años idealmente).**
-

5.2 Tratamiento específico

1. Corrección óptica

- **Lentes ópticos con refracción bajo cicloplejía.**
- Corrige anisometropía o ametropía alta.
- En algunos casos (anisometrópicos leves) **mejora la visión sin medidas adicionales.**

2. Oclusión del ojo dominante (terapia del parche)

- Es el **pilar del tratamiento.**
- Se ocluye el ojo sano para forzar el uso del ambliope.
- Indicaciones:
 - 2–4 h/día si ambliopía leve.
 - 4–6 h/día si moderada.
 - 6–8 h/día si severa.
- Duración: **meses**, con controles cada 4–6 semanas.
- Riesgos: ambliopía del ojo sano (si exceso de oclusión).

3. Penalización óptica o farmacológica

- Alternativa o complemento a la oclusión.
- Se desenfoca el ojo dominante mediante:

- **Lente con +2 a +3 dioptrías** (óptica).
- **Atropina 1% tópica** 2–3 veces/semana (farmacológica).
- Indicado en ambliopía leve-moderada o falta de adherencia al parche.

4. Cirugía (según etiología)

- Si hay **catarata congénita, ptosis, o estrabismo fijo**.
- La cirugía corrige el factor anatómico, pero debe combinarse con estimulación visual.

5. Terapia ortóptica

- Ejercicios de fijación, acomodación y fusión.
- Reforzamiento visual para mantener la mejoría.

5.3 Seguimiento

- Controles cada 4–8 semanas durante la terapia activa.
 - Reevaluación periódica de agudeza visual y fusión binocular.
 - Suspensión gradual del parche (reducción progresiva de horas).
 - Seguimiento hasta los 8–10 años para prevenir recaídas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Reversibilidad
Ambliopía irreversible	No tratada antes del fin del período crítico.	Irreversible.

Ambliopía del ojo dominante	Por exceso de oclusión.	Reversible si se detecta precozmente.
Recaída post-tratamiento	Pérdida de estímulo visual tras suspensión precoz.	Reversible con retratamiento.
Alteraciones psicosociales	Dificultad escolar, baja autoestima.	Mejoran con rehabilitación visual.

Pronóstico:

Excelente si se inicia tratamiento antes de los 6 años.

Disminuye progresivamente después de los 8 años.

La **recuperación completa** puede lograrse en más del **90%** de los casos tratados oportunamente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La ambliopía **siempre es funcional y reversible si se trata precozmente**.
 2. Todo niño con **estrabismo o diferencia visual ≥ 2 líneas** debe ser derivado.
 3. La **oclusión del ojo sano** es la terapia más efectiva.
 4. En **ambliopía refractiva**, la corrección óptica adecuada puede ser suficiente.
 5. La **ambliopía por privación (catarata congénita)** requiere cirugía urgente + estimulación visual.
 6. La plasticidad visual **finaliza cerca de los 8 años**: más allá, los tratamientos son poco efectivos.
 7. Los **controles regulares y la adherencia al parche** son determinantes del éxito.
-

Errores comunes

- No detectar la ambliopía por compensación binocular.
 - No medir visión monocular en controles pediátricos.
 - Iniciar oclusión sin corrección óptica previa.
 - Suspender el tratamiento de forma abrupta.
 - No tratar la causa de base (estrabismo, catarata).
 - No educar a los padres sobre la importancia del tratamiento.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **ambliopía** es una **pérdida visual funcional y reversible** si se trata antes de los 8 años.
2. Se origina por **supresión cortical secundaria** a estrabismo, anisometropía o privación visual.
3. El **diagnóstico es clínico**: disminución de AV con estructuras normales.
4. El **tratamiento incluye corrección óptica + oclusión del ojo sano**.
5. La **derivación temprana (<6 años)** al oftalmólogo es clave para prevenir ceguera funcional.
6. La **recuperación depende de la edad y adherencia** al parche.
7. La **pesquisa visual en APS** es la medida más efectiva para prevenir esta causa de ceguera evitable.